

INDICACIONES USO IMPLANON Y MÉTODOS DE FINANCIACIÓN

DISTRITO SANITARIO CÓRDOBA-GUADALQUIVIR

V_01 (Septiembre 2022)

Los implantes anticonceptivos de gestágenos son métodos anticonceptivos de alta eficacia, siendo eficaces desde el día siguiente a la inserción, y tras su retirada, se produce un rápido retorno a la fertilidad.

Para su implantación, es necesario que en cada UGC haya al menos un profesional entrenado para la colocación y retirada del dispositivo y bien formado para aclarar dudas a las usuarias, del mismo modo que todos los profesionales asistenciales deberían estar informados de las características del método.

El objetivo de este procedimiento es instaurar esta técnica dentro de la cartera de servicios de Atención Primaria dentro del Programa de Planificación Familiar para mujeres que cumplan con criterios para su utilización.

INDICACIONES PARA COLOCACIÓN DE IMPLANTES

Los implantes anticonceptivos constituyen una alternativa en mujeres que pueden presentar un difícil cumplimiento de otros métodos, en aquellas que se desaconseja el uso de estrógenos o cuando rechazan otros métodos seguros como el DIU o los ACHO.

Las mujeres que más se van a beneficiar son:

- Mujeres con factores de riesgo cardiovascular, HTA mal controlada, fumadoras de > 15 cigarrillos y > 35 años, diabéticas de más de 20 años de evolución, obesidad con IMC > 40, predisposición tromboembólica, y en general, en los casos en los que los anticonceptivos combinados estén contraindicados.
- Mujeres que toleran mal los anticonceptivos combinados por náuseas, cefalea, elevaciones de TA o migrañas.
- Mujeres con antecedentes de IVES o gestaciones no deseadas
- Mujeres con más de 4 hijos, o 3 si son < 21 años.
- Mujeres de zonas de transformación social (ZNTS), con factores de riesgo socio-económicos o culturales y malas cumplidoras en general de otros métodos anticonceptivos.
- Uso reiterado de la píldora postcoital

CONTRAINDICACIONES E INTERACCIONES

El uso de Implanon está contraindicado en:

- Embarazo

- Enfermedad Tromboembólica en fase aguda
- Enfermedades hepáticas graves y descompensadas
- Hemorragia genital no diagnosticada
- Cáncer de mama
- Alergia a los componentes
- Tratamiento crónico de inductores enzimáticos del citocromo P450 (fenitoina, fenobarbital, carbamazepina, rifampicina, topiramato...)

EFFECTOS SECUNDARIOS

Son mínimos y no suponen grandes riesgos para la salud. Pueden provocar:

- Muy frecuentes: Infecciones vaginales, cefalea. Acné, aumento de peso, dolor y tensión en las mamas y sangrado irregular
- Frecuentes: Inestabilidad emocional y ánimo deprimido, disminución de la libido, síntomas gastrointestinales, aumento del apetito, sofocos, dolor y picor en zona de inserción y dolor tipo menstrual.
- Poco frecuentes: Picor genital, ansiedad, migrañas, insomnio, algias generalizadas e infección de orina.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

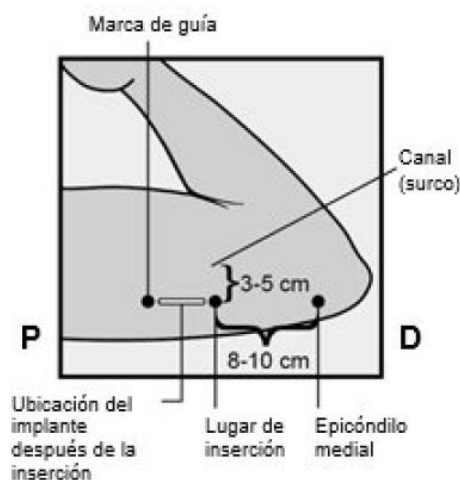
- Pacientes que tengan dudas o no acepten el patrón de sangrado
- Pacientes muy preocupadas por la ganancia de peso o aparición de acné
- Pacientes en tratamiento psiquiátrico con polifarmacia aunque la medicación no interaccione (valoración individual)
- Deseo de gestación en menos de 3 años
- Se ha retirado otro implante anterior antes de los 3 años por efectos secundarios u otra causa.
- Mujeres que puedan usar estrógenos por no estar contraindicados y no pertenezca a los colectivos antes reseñados.
- Mujeres mayores de 40 años, en cuyo caso el tratamiento de elección es el DIU.

COLOCACIÓN DEL IMPLANTE

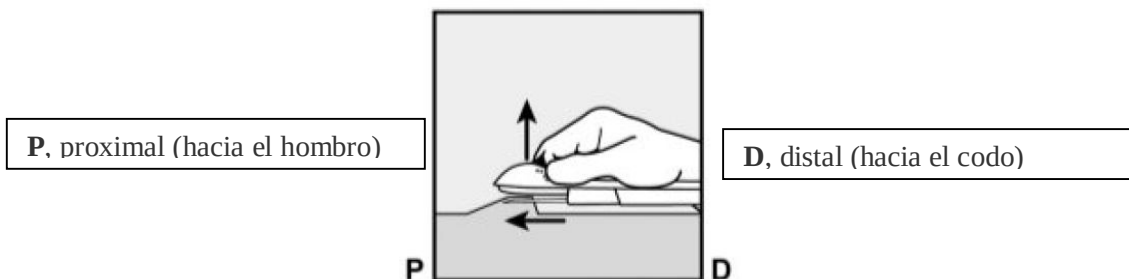
- La inserción de Implanon NXT debe realizarse únicamente por un profesional sanitario cualificado que esté familiarizado con la técnica.
- Para facilitar la inserción del implante, tumbese de espaldas, con su brazo flexionado a la altura del codo y su mano debajo de su cabeza (o lo más cerca posible).



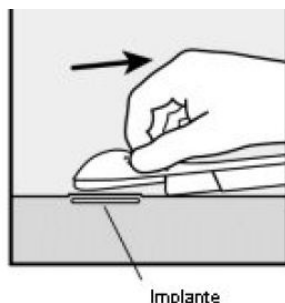
- El implante se insertará en la cara interna del brazo no dominante (el que no utiliza para escribir) a unos 8-10 cm del epicóndilo interno, previa anestesia de la zona con lidocaína/epinefrina al 1%



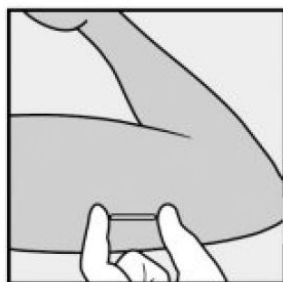
- Se marcará en la piel el lugar de la inserción, y se desinfecta el lugar de inserción y se anestesia.
- Se estira la piel y se inserta la aguja **directamente** debajo de la piel. Una vez que la punta está dentro de la piel, se inserta completamente en un movimiento paralelo a la piel.



- Se desbloquea la lengüeta deslizante de color púrpura con el fin de retraer la aguja. El implante permanecerá en la parte superior del brazo cuando se retire la aguja.



- La presencia del implante debe ser verificada tocando la zona en la que ha sido implantado inmediatamente después de la inserción (palpándola). En un implante correctamente insertado el profesional sanitario y usted podrán notar sus extremos entre los dedos índice y pulgar. Debe tenerse en cuenta que la palpación no garantiza al 100% la presencia del implante.



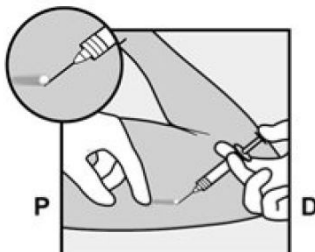
- En el caso de que el implante no pueda ser palpado o cuando su presencia sea dudosa, deben utilizarse otros métodos para confirmar la presencia del implante. En estos casos, una vez localizado el implante debe ser extraído.
- Tras la colocación, se colocará un vendaje adhesivo pequeño sobre el lugar de inserción y para reducir al mínimo el hematoma se colocará un vendaje compresivo que puede retirarse a las 24 horas (el adhesivo sobre el lugar de inserción debe quitarse entre los 3-5 días).
- Después de la inserción del implante, se le dará una Tarjeta de Información para la Paciente en la que se indicará el lugar de la inserción, la fecha de inserción y la fecha límite en la que el implante debe ser extraído o sustituido.

RETIRADA DEL IMPLANTE

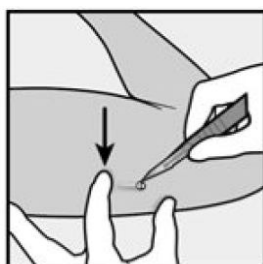
- El implante se puede extraer cuando usted lo pida o **como máximo tres años después de haber sido insertado**. La localización del lugar de la inserción del implante se indica en la Tarjeta de Información para la Paciente.
- Para facilitar la extracción del implante, debe tumbarse de espaldas, con su brazo flexionado a la altura del codo y su mano debajo de su cabeza (o lo más cerca posible).



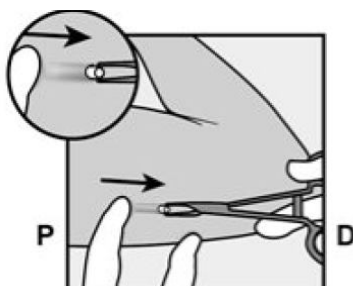
- La zona superior de su brazo será desinfectada y anestesiada.



- Se realizará una pequeña incisión a lo largo del brazo, justo debajo del extremo del implante.



- El implante se empuja suavemente hacia el lugar de la incisión y se retira con pinzas.



- La incisión se cierra con suturas cutáneas adhesivas estériles, que podrán retirarse a los 3-5 días de la inserción, o sutura, en cuyo caso se retiran a los 7-8 días.

MOMENTO PARA LA INSERCCIÓN

- La inserción se realizará en los primeros 5 días del inicio de un ciclo normal, lo que asegura que no hay embarazo.
- Se puede insertar inmediatamente tras un aborto del primer trimestre.

- Puede insertarse 3-4 semanas después del parto si no hay lactancia.
 - Si se inserta a la semana 4ª postparto, hay que usar mecanismo de barrera durante 1 semana.
 - Si hay lactancia, esperar 6 semanas
- En el caso de cambio de método:
 - Implante o DIU: El mismo día de la retirada
 - Método inyectable: Esperar a la fecha que toca la siguiente dosis
 - ACHO, parcho o aro vaginal: Se puede insertar cuando empieza el periodo de descanso y hasta el día del comienzo del nuevo envase así se estará razonablemente seguro de que la mujer no está embarazada. Si está tomando sólo gestágenos, puede utilizarse en cualquier momento

REVISIONES

A las mujeres portadoras de implantes anticonceptivos se les debe hacer una primera revisión a los 3 meses y posteriormente anual, dónde fundamentalmente se evalúe el patrón de sangrado así como la correcta colocación del implante, además de la posible aparición de reacciones locales o efectos secundarios.

PATRÓN DE SANGRADO. EVALUABLE A LOS 3 MESES	
Sangrado regular	3 episodios de sangrado de 5 días cada uno.
Amenorrea	No sangrado
Sangrado frecuente	Menos de 2 episodios de sangrado o manchado
Sangrado infrecuente	Más de 4 episodio de sangrado o manchado
Sangrado irregular	Diferencia intervalo libre más corto y más largo > 17 días
Sangrado prolongado	Episodio de sangrado de 10 días de duración o más
Episodio de sangrado	Se requiere uso de compresas u otra protección
Episodio de manchado	No precisa uso de protección sanitaria

PRESCRIPCIÓN Y FINANCIACIÓN

Dentro de la prestación farmacéutica, Implanon está catalogado como medicamento de Diagnóstico Hospitalario y su financiación por el SNS está sujeta a visado, por lo que la indicación del tratamiento requiere un informe de un médico especialista en Ginecología y Obstetricia.

No obstante y con el fin de garantizar una protección anticonceptiva adecuada a las mujeres consideradas de riesgo o con contraindicación al uso de estrógenos sin perjuicio de un retraso

en el inicio de la anticoncepción, desde el Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir se procederá al **suministro directo al centro de salud** que lo solicite para las mujeres que cumplan con los siguiente requisitos:

- Mujeres de ZNTS o con factores de riesgo socio-económicos o culturales
- Antecedentes de IVE o menores con gestación no deseada
- Patología previa con contraindicación para tomar estrógenos (Criterios OMS) Anexo 1
- Mujeres > 35 y < 40 fumadoras de más de 15 cigarrillos al día.
- Mujeres de < 21 años con 3 hijos o > 21 con 4 o más.

Serán subsidiarias de **financiación por parte del SNS mediante prescripción y visado** por parte del Servicio de Ginecología el resto de situaciones en las que se pueda plantear el uso de este método anticonceptivo, como son:

- Mujeres que toleran mal los anticonceptivos combinados
- Uso reiterado de píldora postcoital
- Mujeres con patología psiquiátrica que no tome medicación que interaccione tras una valoración individual

Y **no serán financiados** aquellos que cumplan criterios de exclusión.

CIRCUITOS DE SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN.

1.- SUMINISTRO DIRECTO AL CENTRO DE SALUD

A aquellas mujeres que cumplan los criterios arriba mencionados, se les suministrará directamente desde el área de farmacia del distrito el dispositivo para su colocación en el centro de salud.

Para ello, los centros enviarán cumplimentado al área de farmacia el Anexo 2, donde se recogen los datos de la mujer y se detalla la causa por la que se solicita. Una vez valorado y aceptado, el envío del dispositivo se hará al centro de salud a través del TRM, adjuntando el anexo 2 cumplimentado para su archivo y custodia en el centro de salud.

2.- PRESCRIPCIÓN Y VISADO POR PARTE DEL SERVICIO DE GINECOLOGÍA

En estos casos se procederá a la derivación a Ginecología, indicando en el motivo de consulta la necesidad de prescripción y visado de este método anticonceptivo. Esta derivación se hará a través del circuito tradicional de Primera de Atención Primaria (PAP) hasta que esté operativa la Teleconsulta (TC) para esta especialidad.

Una vez realizada la prescripción y visado, tras retirarlo de la farmacia, la paciente pedirá cita en su centro de salud para la implantación.

3.- ADQUISICIÓN DIRECTA POR LA USUARIA (PRESCRIPCIÓN NO FINANCIADA)

A aquellas mujeres con criterios de exclusión para el uso de implantes anticoncepción, pero que muestren su disposición a utilizar este método anticonceptivo, se les hará una prescripción por parte de Atención Primaria, indicando en la prescripción que es un producto no financiado.

Una vez retirado de la oficina de farmacia, pedirá cita en su centro de salud para la implantación.

SISTEMAS DE REGISTRO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN

A todas las mujeres que vayan a utilizar este método anticonceptivo se les debe cumplimentar el Anexo 3, donde se recogerán datos personales y de salud.

Este anexo, junto con el Anexo 2 en caso de suministro por parte del Distrito, así como el Consentimiento Informado para la implantación, obligatorio en todos los casos, será archivado y custodiado por parte del centro de salud.

ANEXO 1

CONTRAINDICACIÓN PARA LA TOMA DE ESTROGENOS (OMS)

CATEGORÍA 4	CATEGORÍA 3
• Lactancia materna en las primeras 6 semanas. • Tabaquismo de más de 15 cigarrillos/día en mayores de 35 años. • Obesidad >40 IMC. • Múltiples factores de riesgo cardiovascular (edad, tabaco, diabetes, hipertensión, perímetro cintura >88 cm.) • Hipertensión arterial no controlada: sistólica mayor de 160 mm Hg o diastólica mayor de 100 mm Hg. • Antecedentes personales de trombosis venosa profunda (TEV) o embolismo pulmonar (EP). • TEV/EP actual. • Cirugía mayor con inmovilidad prolongada. • Trombofilia familiar diagnosticada: situaciones en las que existen mutaciones de genes con carácter trombogénico. • Cardiopatía isquémica. • Ictus isquémico. • Valvulopatía complicada con hipertensión pulmonar, fibrilación auricular, historia de endocarditis o prótesis metálicas. • Diabetes Mellitus de más de 20 años de evolución o asociada con vasculopatía, neuropatía o nefropatía. • Cefaleas migrañosas con aura. • Migraña sin aura en mayores de 35 años. Historia actual de cáncer de mama (últimos 5 años). • Hepatitis viral activa. • Cirrosis descompensada. • Adenoma hepático o hepatocarcinoma	• Lactancia materna entre las 6 semanas postparto y los 6 meses. • Postparto inmediato sin lactancia (primeras 3 semanas). • Tabaquismo de menos de 15 cigarrillos/día en mayores de 35 años. • Edad mayor de 35 años y sin fumar menos de un año. • Obesidad 35-39 IMC. • Hipertensión no controlada sistólica de 140-159 mm Hg o diastólica de 90-99 mm Hg. • Inmovilidad no relacionada con la cirugía. • Sospecha de trombofilia por antecedente personal no filiado, antecedente familiar de primer grado < 45 años o localización atípica. • Ictus hemorrágico. • Hiperlipemia con otros factores de riesgo. • Migraña sin aura en menores de 35 años continuadoras. • Migraña sin aura en mayores de 35 años iniciadoras. • Historia anterior de cáncer de mama (antes de los últimos 5 años). • Enfermedad vesicular activa actual y/o en tratamiento médico. • Historia de colestasis asociada a la toma de previa de AH. • Cirrosis hepática compensada. • Toma de fármacos como rifampicina

ANEXO 2

SOLICITUD DE SUMINISTRO DE IMPLANON

NOMBRE Y APELLIDOS: _____

TELÉFONO: _____ NHUSA: _____

FECHA NACIMIENTO: _____ (____ AÑOS)

FECHA SOLICITUD: _____ CENTRO: _____

PROFESIONAL QUE LO SOLICITA: _____

MOTIVO		
SUMINISTRADA POR DISTRITO	Mujeres de ZNTS o con factores de riesgo socio-económicos o culturales	
	Antecedentes de IVE o menores con gestación no deseada	
	Patología previa con contraindicación para tomar estrógenos (Criterios OMS): Cual: _____	
	Mujeres > 35 y < 40 fumadoras de más de 15 cigarrillos al día.	
	Mujeres de < 21 años con 3 hijos o > 21 con 4 o más	

(A completar por Farmacia Distrito)

Tras la revisión de la historia y valorada la solicitud de suministro de implante anticonceptivo subdérmico (Implanon ®) realizada en este documento, desde el área de farmacia se considera esta solicitud

☐ FAVORABLE

☐ DESFAVORABLE (Especificar motivos): _____

Fdo: _____

Fecha: _____

ANEXO 3

HOJA DE REGISTRO DE USUARIAS DE IMPLANTES ANTICONCEPTIVOS

NOMBRE Y APELLIDOS: _____

TELÉFONO: _____ NHUSA: _____

FECHA NACIMIENTO: _____ (____ AÑOS)

ADQUISICIÓN (Marcar con una X)		
SUMINISTRADA POR DISTRITO	Mujeres de ZNTS o con factores de riesgo socio-económicos o culturales	
	Antecedentes de IVE o menores con gestación no deseada	
	Patología previa con contraindicación para tomar estrógenos (Criterios OMS): Cual: _____	
	Mujeres > 35 y < 40 fumadoras de más de 15 cigarrillos al día.	
	Mujeres de < 21 años con 3 hijos o > 21 con 4 o más	
PRESCRIPCIÓN GINECOLOGIA	Mujeres que toleran mal los anticonceptivos combinados	
	Uso reiterado de píldora postcoital	
	Mujeres con patología psiquiátrica que no tome medicación que interaccione tras una valoración individual	
	Otras: _____	
NO FINANCIADA	Especificar: _____	

TENSIÓN ARTERIAL: _____ PESO: _____ TALLA: _____ IMC: _____

FECHA ÚLTIMA REGLA: _____ MÉTODO ANTERIOR: _____

Fecha inserción implante: _____ **Fecha retirada aconsejada:** _____

REVISIONES PROPUESTAS

- A los 3 meses:

(Describir incidencias)

- Al año:

(Describir incidencias)
